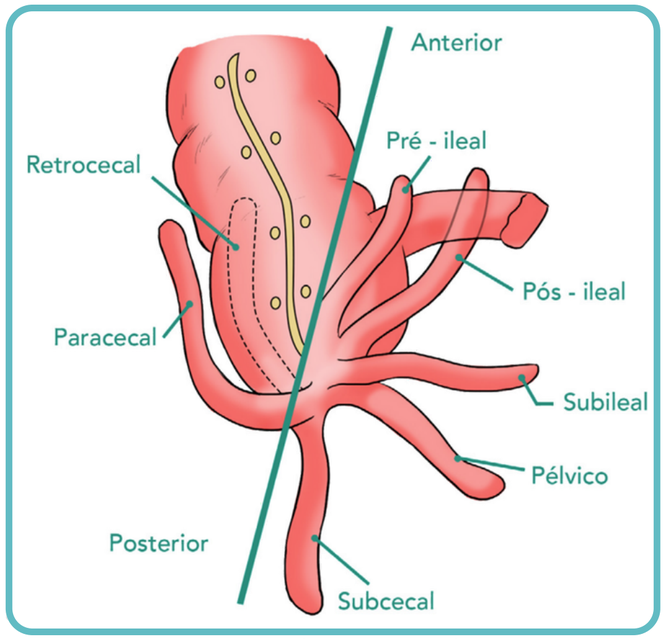
Apendicite



Posições do apêndice

ANATOMIA

- Divertículo verdadeiro, com comprimento médio de 9 cm e largura até 5 mm
- Localização: base do ceco, na convergência das tênias
- Irrigação: A. apendicular, ramo da a. ileocecocólica
- Posição mais comum: retrocecal (60%), pélvico (30%)

EPIDEMIOLOGIA

- Mais comum em homens, brancos
- 2ª e 3ª décadas
- 6 a 7% da população
- Principal causa de abdome agudo (geral e gestante)

FISIOPATOLOGIA

Principal causa:
Adulto: fecalito ou apendicolito
Criança: hiperplasia linfoide

Obstrução da luz apendicular → Isquemia → Necrose → Perfuração → Abcesso / Peritonite

Flora bacteriana: Bactérias Gram-negativas (*Echerichia coli*) e anaeróbias (*Bacterioides fragilis*)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Apendicite

QUADRO CLÍNICO

Dor periumbilical com irradiação para a fossa ilíaca direita, associada a anorexia, náuseas, vômitos e febre baixa (< 38°C).

EXAME FÍSICO

Sinal	Descrição
Blumberg	Descompressão brusca positiva no ponto de McBurney
Rovsing	Dor no quadrante inferior direito com a palpação do quadrante inferior esquerdo
Lapinsky	Dor no quadrante inferior direito, com extensão passiva do quadril ipsilateral
Iliopsoas	Dor à extensão do quadril direito, com o paciente em decúbito lateral esquerdo
Obturador	Dor hipogástrica com a flexão da coxa seguida de rotação interna do quadril direito
Dunphy	Dor em fossa ilíaca direita que piora com a tosse

LABORATÓRIO

- ✓Leucocitose com desvio à esquerda
- ✓Aumento da PCR
- ✓Urina I: hematúria, leucocitúria pélvica, irritação da bexiga

ESCORE DE ALVARADO

Escore de Alvarado		
	Característica	Pontuação
Sintomas	Dor migratória	1
	Anorexia	1
	Náusea e/ou vômito	1
Sinais	Defesa da parede no quadrante inferior direito	2
	Descompressão brusca no quadrante inferior direito	1
	Febre > 37,5 °C	1
Laboratório	Leucocitose da contagem de glóbulos brancos > 10 x 10^9/litro	2
	Desvio à esquerda	1
Total		10

0-3 pontos	Apendicite pouco provável = investigar outras patologias
⩾ 4 pontos	Provável apendicite = solicitar exame de imagem se necessário
⩾ 7 pontos	Alto risco de apendicite = cirurgia, solicitar exame de imagem se necessário (mulheres, idosos, imunocomprometidos, gestantes)

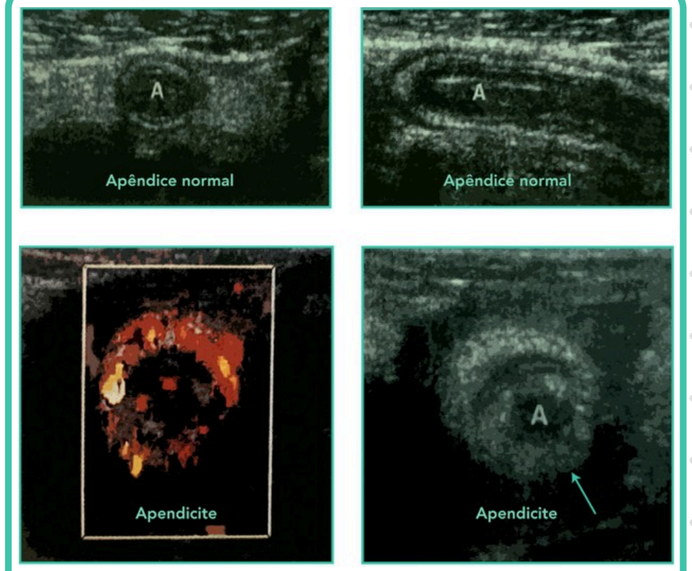
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Apendicite

EXAMES COMPLEMENTARES

Ultrassonografia

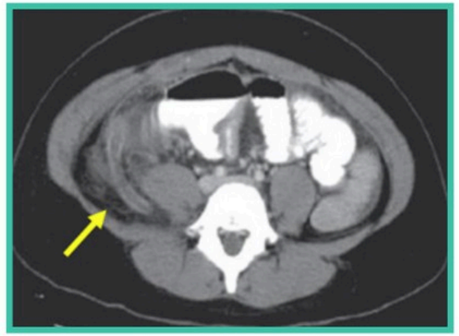
- Principalmente em gestantes e crianças
- Diâmetro > 6 mm, líquido livre na pelve
- Apêndice aumentado, imóvel e não compressível
- Apêndice não visível não descarta o diagnóstico!



Apendicite: aumento da vascularização e imagem em alvo (espessamento da parede).

Tomografia (contraste EV)

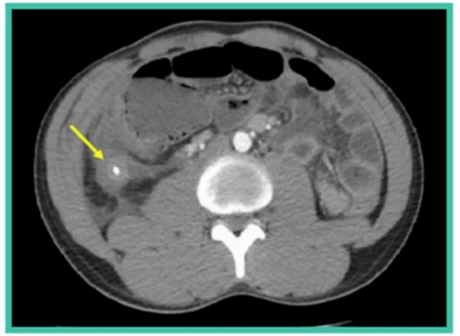
- Exame de escolha
- Fecalito, borramento da gordura, abscesso, líquido verde, pneumoperitôneo
- Sinal do alvo: diâmetro apendicular ⩾ 7 mm, espessamento da parede apendicular (⩾ 2 mm)
- Alta sensibilidade (90-100%) e especificidade (91-99%)
- Desvantagens: irradiação e contraste



Fonte: prova acesso direto
FAMEMA 2019



Fonte: prova de acesso direto
USP 2020



Fonte: acervo pessoal
Dra. Renatha Paiva

Ressonância

Exame de escolha na gestante se ultrassom for inconclusivo

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Apendicite

DIAGNÓSTICO

- O diagnóstico da apendicite aguda é eminentemente clínico!
- Jovem, masculino, com quadro típico de apendicite aguda, com evolução < 48 h = apendicectomia VLP.

FASES DA APENDICE

Fase	Características	Complicações
0	Apêndice normal.	
I	Apêndice com hiperemia e edema (catarral).	Apendicite não complicada.
II	Apêndice com exsudato fibrinoso (flegmonosa).	
III	Apêndice com necrose e abcesso (supurativa).	Apendicite complicada.
IV	Apendicite perfurada (gangrenosa).	

Classificação adotada pela USP-SP:

- Estágio I: edematosa - apêndice edemaciado, com aspecto próximo ao normal.
- Estágio II: úlcero-flegmonosa - aumento importante da vascularização, tornando-o edemaciado e avermelhado.
- Estágio III: fibrino-purulenta - apendicite supurada, em que o apêndice é circundado por fibrina e secreção.
- Estágio IV: necrose ou perfuração - quando há necrose da parede do apêndice, podendo haver perfuração e extravasamento de conteúdo intestinal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Causas ginecológicas	• Doença Inflmatória Pélvica • Abscesso tubo-ovariano • Torção de ovário • Gravidez ectópica • Cisto ovário roto
Causas intestinais	• Adenite mesentérica • Ileíte aguda • Apendagite • Doença de Crohn • Diverticulite • Meckel • Neoplasias
Causas urológicas	• Ureterolitíase • Cistite • Pielonefrite

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Estratégia MED

Apendicite

TRATAMENTO



Apendicite aguda não complicada

Apendicectomia (de preferência por laparoscopia) e antibioticoprofilaxia pré-operatória em dose única.

Alguns autores indicam o tratamento clínico com antibioticoterapia (alto índice de recorrência: 30% em quatro a sete meses).

Apendicite complicada: peritonite difusa ou paciente instável

Cirurgia de emergência (laparotomia ou laparoscopia, se houver estabilidade) e antibioticoterapia por quatro a sete dias. É necessária reanimação antes da cirurgia.

Apendicite aguda complicada: paciente estável, abscesso bloqueado

- Abscesso passível de drenagem: drenagem percutânea guiada por exame de imagem e antibioticoterapia por quatro a sete dias. Se não for possível a drenagem via percutânea, poderá ser realizada via transvaginal, transretal ou, ainda, por laparoscopia. Apendicectomia de intervalo posteriormente.
- Abscesso não passível de drenagem ou presença de "fleimão": antibioticoterapia por quatro a sete dias e apendicectomia de intervalo posteriormente.
- Apendicectomia de intervalo: consiste no tratamento não cirúrgico, inicialmente com antibioticoterapia por quatro a sete dias e/ou drenagem do abscesso, colonoscopia em seis a oito semanas (adultos) para excluir neoplasia e programar apendicectomia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina